Número do processo: 0724720-44.2025.8.07.0001

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: N. B. S.
REPRESENTANTE LEGAL: LORNA MORAIS BATALHA

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

N.B.S., representado por sua genitora, ajuizou ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, partes qualificadas.

Aduz o autor que é beneficiário de plano de saúde administrado pela Sul América Companhia de Seguro Saúde e, diante de dificuldades no crescimento, procurou atendimento médico, sendo, que, após exames laboratoriais e de imagem (ressonância magnética de crânio com sela túrcica), diagnosticou déficit estatural importante, compatível com baixa produção de hormônio do crescimento (GH), além de idade óssea atrasada e previsão de estatura final (PEF) abaixo do canal familiar.

Aventa que o tratamento indicado consiste no uso contínuo do medicamento Norditropin (Somatropina) 15mg, na dosagem de 1mg por dia, via subcutânea, à noite, com prescrição de quatro canetas por mês.

Alega que o pedido de autorização e custeio junto à requerida foi negado, sob a justificativa de ausência do medicamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sustenta que, diante da negativa e da urgência do tratamento, sua genitora foi compelida a adquirir o medicamento com recursos próprios, contando com ajuda de familiares, tendo despendido até a presente data o montante de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais), bem como o do tratamento é de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo estimado pelo prazo de doze meses, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este inviável para o orçamento familiar.

Acresce que a negativa da requerida causou profundo abalo emocional, angústia e ansiedade ao autor e seus familiares, configurando dano moral, diante da incerteza quanto à continuidade do tratamento e da luta por um direito básico à saúde.

Defende que o referido medicamento é o único para fins de melhoria da estatura final do paciente. Aventa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e requer a inversão do ônus probatório. Pugna por gratuidade de justiça e por concessão de tutela de urgência para que a parte requerida seja obrigada a custear todo o tratamento, em

especial, o fornecimento do medicamento somatropina, consoante prescrição médica. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Junta documentos.

Determinada a emenda à inicial, houve o recolhimento das custas iniciais, ID. 237170924, e juntada da petição e documentos de ID. 238351107.

Tutela de urgência não concedida – ID. 238363310. Interposto agravo de instrumento, foi indeferido efeito suspensivo (ID. 241618473).

Citada, a requerida apresentou contestação em ID nº 241100100 (https://pje.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/1g/4343642/241100100).

Afirma, em sede preliminar, a inépcia da inicial por ausência de pedido certo e determinado, em violação aos arts. 322 e 324 do CPC, já que os pedidos não trazem especificação dos insumos pretendidos com codificação, quantidade, valores e indicação de cláusula que respalde sua cobertura e que, tais pedidos, da forma como formulados, geram insegurança jurídica. Ainda em preliminar, aduz a falta de interesse de agir uma vez que a parte não demonstrou ter formulado qualquer pedido de cobertura do medicamento perante a operadora, não tendo demonstrado, tampouco, recusa formal ou indeferimento administrativo da solicitação.

Impugna o pedido de gratuidade de justiça e o valor dado à causa, fixado em R$ 30.000,00, uma vez que somente o pedido de indenização a título de danos morais pode ser considerado pedido certo e determinado, requerendo o ajuste do valor para que conste como sendo de R$ 15.000,00.

Assevera que a inicial não está instruída com documentos indispensáveis para a propositura da ação, restando necessário o preenchimento dos requisitos previstos na nova redação do §13, do art. 10 da Lei 9.656/98 que prevê que a cobertura não prevista no rol somente deverá ser autorizada se: i) existir comprovação da eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ii) existir recomendações da CONITEC; iii) existir recomendação de no mínimo 1 órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que aprovadas também para seus nacionais.

No mérito, aduz que o contrato firmado entre as partes está em consonância com a Lei Federal e com o determinado pela ANS não cobre o medicamento SOMATROPINA uma vez que: o medicamento é de uso domiciliar (exclusão expressa na cláusula 15.12); não foram preenchidos os requisitos da Diretriz de Utilização 65 da ANS; o medicamento não consta do Rol da ANS; e há extensa jurisprudência do STJ reconhecendo como lícita a exclusão de medicamentos de uso domiciliar.

Impugna os documentos e a nota técnica apresentados, em como diz inexistir ato ilícito, não havendo, assim, que se falar em indenização por danos morais.

Réplica de no ID. 243825510 (https://pje.tjdft.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/TJDFT/1g/4343642/243825510).

Manifestação do Ministério Público no ID. 244150510 e ID. 244321509.

Decisão de saneamento do processo no ID. 245752450. Foram rejeitadas as preliminares e aberto prazo para o autor juntar outros documentos médicos.

Nota técnica do NatJus no ID. 250083376. As partes foram intimadas para se manifestar sobre a Nota Técnica, petição da requerida (ID. 252885136) e do autor (ID. 252961859).

Manifestação do Ministério Público no ID. 253028509.

Relatados. DECIDO.

Considerando que o processo foi saneado e não há necessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao requerente.

Para o julgamento da causa, cabe observar os seguintes parâmetros objetivos atinentes à temática em debate, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que:

(i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

(EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022)

Pois bem, a baixa estatura pode ser dividida em patológica e idiopática. A patológica é subdividida em proporcional e desproporcional. Aquela inclui o raquitismo e as displasias ósseas, sendo que esta ainda se subdivide em: de origem pré-natal (retardo de crescimento intrauterino, síndromes dismórficas e cromossomopatias, como síndrome de Turner, Down, Russel-Silver, Noonan) e de origem pós-natal (do organismo em geral, além de psicossocial, nutricional e endocrinopatias).

Na presente hipótese, a controvérsia se estabelece em torno de hipopituitarismo apresentado pelo requerente, que é a condição em que a hipófise (glândula pituitária) produz uma quantidade insuficiente de hormônios (CID E23.0), conforme relatório médico de ID. 235630682:

RELATORIO MÉDICO

PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRICO DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO. PEF ABAIXO DO CANAL FAMILIAR E BAIXA VELOCIDADE DE CRESCIMENTO.
NECESSITA FAZER USO REGULAR E RIGOROSO DE NORDITROPIN, PARA POTENCIALIZAR O GANHO ESTATURAL. RECEITA EM ANEXO.
NECESSITA DE CONSULTAS PERIODICAS, REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM DE ROTINA.

CID E23.0

BRASILIA/DF, 19 DE MARCO DE 2025.

Delmir Rodrigues
CRM/DF 14.480
CPF 672.462.792-68

DELMIR RODRIGUES
Endocrinologia e Nutrologia Pediátrica e do Adolescente
CRM/DF 14.480

O hipopituitarismo é uma disfunção hormonal onde a glândula hipófise não produz hormônios de crescimento suficientes, sendo um problema endocrinológico e, portanto, se configura como baixa estatura patológica (BET).

No entanto, o relatório médico conflita com o documento apresentado no ID. 238351144, radiografia que atesta a compatibilidade óssea com a idade cronológica de dezoito anos, estando o requerente com dezessete anos.

Assim, os documentos não provam que o postulante se encaixa, especificamente, nos casos que autorizam a cobertura pelo plano de saúde, como também não preenche as situações excepcionais previstas na legislação de regência.

Destaco que, na decisão saneadora, ainda **foi oportunizado ao autor juntar outros documentos médicos passíveis de fundamentar sua pretensão** (ID. 245752450), mas se manteve inerte.

Nesse giro, a Lei nº 14.454/2022 impôs aos planos e seguros de saúde a cobertura de tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, instituindo verdadeira taxatividade mitigada, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos, a saber: a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (art. 10, incisos I e II do § 13, Lei nº 9.656/98).

A seu turno, a Lei 9.656/98, no art. 10, inc. VI, não incluiu o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que é o caso da Somatropina, salvo nas hipóteses excepcionais descritas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12. Confira-se:

“Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...).”

Por sua vez, os incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, do artigo 12 da Lei 9.656/98 estabelecem que: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no planoreferência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.”

É possível extrair da norma referida supra, que os seguros/planos de saúde somente estão obrigados à cobertura de medicamento vinculado a tratamento domiciliar, desde que antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais de uso oral e, por lógica, aos medicamentos destinados ao controle dos efeitos adversos, bem assim dos medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento oral e/ou venoso. Também se submetem ao dever de disponibilizar os procedimentos radioterápicos para

tratamento de câncer e hemoterapia, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar, procedimentos que não guardam semelhança com o caso ora posto.

Acresço à fundamentação retro que o NatJus – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, o qual auxilia na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos - tem se manifestado desfavoravelmente em situações muito semelhantes à do demandante. Vide notas técnicas nº 2054, 2053, 1549, 1196, 377 e 344.

Em especial, na Nota Técnica elaborada para o caso específico desses autos, juntada no ID. 250083376, o NatJus concluiu que:

*"**9. CONCLUSÃO***

O relatório apresentado é incompleto, não traz dados indispensáveis (estatura, altura alvo, curva de crescimento, curva de função somatotrópica, exames laboratoriais e imagem hipofisária) e indica idade óssea de 18 anos, compatível com maturidade esquelética plena. Nessa condição, não há mais possibilidade de ganho estatural com somatropina.

Conforme o PCDT da Deficiência de Hormônio de Crescimento/Hipopituitarismo (CONITEC, 2018), o tratamento é restrito a crianças e adolescentes com potencial de crescimento linear, sendo a continuidade após a transição justificada apenas em casos de deficiência persistente comprovada, o que não se aplica no caso em tela.

*Dessa forma, o fornecimento de somatropina não encontra respaldo de custo-efetividade, configurando intervenção sem benefício clínico, de alto custo, não havendo fundamento técnico. Desta forma, este NATJUS se manifesta como **NÃO FAVORÁVEL** à demanda pela somatropina. "*

Não bastassem os argumentos retro, o medicamento pretendido pelo autor é de uso domiciliar e, portanto, sendo lícita a exclusão do seu fornecimento.

Confira-se:

"CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE CRESCIMENTO. MEDICAMENTO GENOTROPIN. USO DOMICILIAR. NEGATIVA LÍCITA DE COBERTURA. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. No caso em exame, o medicamento Genotropin não se inclui nas hipóteses de inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar, razão pela qual, em não se tratando de medicamento de administração intravenosa, a recusa de custeio ao tratamento, por parte do plano de saúde, não pode ser considerada abusiva.

3. De acordo com jurisprudência desta Corte Superior, a oposição de embargos de declaração, com o fim de prequestionamento não possui caráter protelatório, não ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 (Súmula 98 do STJ).

4. Recurso especial parcialmente provido, para afastar a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

(REsp n. 2.214.433/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Soma-se a isso o fato de que os genitores têm arcado com os custos do medicamento desde o início do tratamento.

Por todo o exposto, é possível concluir que apesar da previsão de cobertura do hormônio do crescimento no rol da ANS, não se pode obrigar o plano à cobertura da medicação de forma indiscriminada. Necessário seria que o autor se encaixasse nos critérios definidos pelos protocolos clínicos e pelas diretrizes terapêuticas, o que não restou materializado nos autos.

Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. RELATÓRIO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DEFICIÊNCIA DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO – HIPOPITUITARISMO. RADIOGRAFIA DE IDADE ÓSSEA. GRANDE AVANÇO NÃO DEMONSTRADO. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

3. No caso, o medicamento Somatropina prescrito a autora foi inserido no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência de Hormônio do Crescimento-Hipopituitarismo" aprovado pela Conitec em março de 2018.

4. Entretanto, os documentos acostados aos autos não comprovam suficientemente que a autora preenche os requisitos estabelecidos no protocolo clínico estabelecido pela Conitec, o que seria necessário.

5. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 2027528, 0713560-81.2023.8.07.0004, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.)

De outro lado, não merece acolhimento a alegação autoral de que o tratamento pleiteado deve ser realizado em regime de urgência ou emergência, com vistas a suprir os requisitos legais anteriormente mencionados.

Nos termos da Resolução nº 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina, define-se urgência como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”, e emergência como “a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”.

A Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, reforça essas definições ao dispor, em seu art. 35-C, que é obrigatória a cobertura nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos requisitos legais para enquadramento da situação como emergência ou urgência. Não há risco imediato de vida, tampouco lesões irreparáveis ao paciente.

Tal entendimento é corroborado pela Nota Técnica do NatJus (ID. 250083376, item 9.3), que conclui pela ausência de urgência/emergência.

Diante da ausência de amparo legal e técnico para o pedido, impõe-se a sua improcedência.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, o autor arcará com o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Oficie-se, com urgência, à 1ª Turma Cível, Exmo. Des. Carlos Martins, AGI n. 0742476-06.2024.8.07.0000, informando sobre o julgamento do feito.

Publique-se e intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Assinatura e data conforme certificado digital

Assinado eletronicamente por: **FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA**
16/10/2025 15:30:23
https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25101615302320100000230

IMPRIMIR GERAR PDF